

MASOTERAPIA I

Semana 04

MASAJE CABEZA – CARA – CERVICALGIA - PRACTICA

Docente

Lic. Gilmer Emilio Malca C.

Presente.

¿Cómo realizar un masaje en zona cervical?



- **VIDEO DEMOSTRATIVO: Observar el video.**
- <https://www.youtube.com/watch?v=H7JIAeTc744>

- **LOGRO:**
- Que alumno identifique los principales técnicas usadas en la zona cervical así como estiramientos.

- **OBSERVE LA IMAGEN:**





Cabeza:

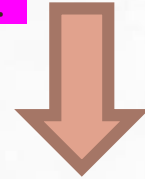


❑ La cabeza es la parte primordial del cuerpo

- La cabeza alberga el encéfalo, el centro de control del cuerpo



- La cabeza es la residencia exclusiva de cuatro de los cinco sentidos tradicionales, pues alberga los órganos de la visión, la audición, el gusto y el olfato.



Además, la cabeza contiene los órganos principales del equilibrio.



*Los músculos de la cabeza, la cara y el cuello
pueden clasificarse:*

- ✓ Músculos del cuero cabelludo, sobre todo el occipital y el frontal (u occipitofrontal, si se ve como un solo músculo), y las caras más dorsales del temporal. Estos músculos mueven el cuero cabelludo y la frente.



- Músculos de la mandíbula, que abren y cierran la boca al mover la mandíbula.

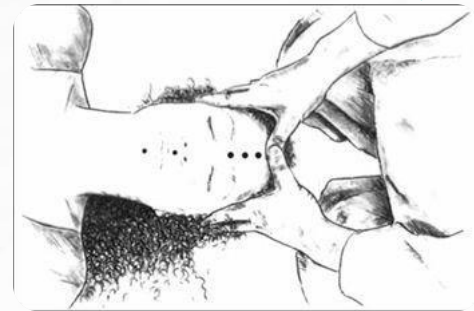
- ❖ Músculos del cuello, que sujetan y equilibran la cabeza sobre la columna vertebral y la mueven en todas las direcciones
- 

Beneficios del masaje

- Reduce y elimina los fuertes dolores de cabeza, jaquecas y migrañas.
- ✓ Activa la circulación sanguínea en esta zona lo que ayuda para el aporte de nutrientes a nuestro Cabello consiguiendo retardar la Caída del Cabello.
- Elimina el dolor cervical.
- ❖ Elimina la tensión acumulada en cuello y hombros.



❑ CUANDO TRATEMOS LAS ZONAS DE LA CABEZA, SOBRE TODO EL CUELLO, DEBEMOS PRESIONAR DESPACIO Y UTILIZAR TODO EL PULPEJO DEL DEDO DEBIDO ES UNA ZONA MUY SENSIBLE.



□ Frontal



Palpación

Presionar ligeramente con las yemas de los dedos sobre la frente entre la línea del pelo y las cejas. La arquitectura del músculo es paralela, y la dirección de las fibras es superior/inferior. Cuanto más tenso esté el músculo más palpable será.



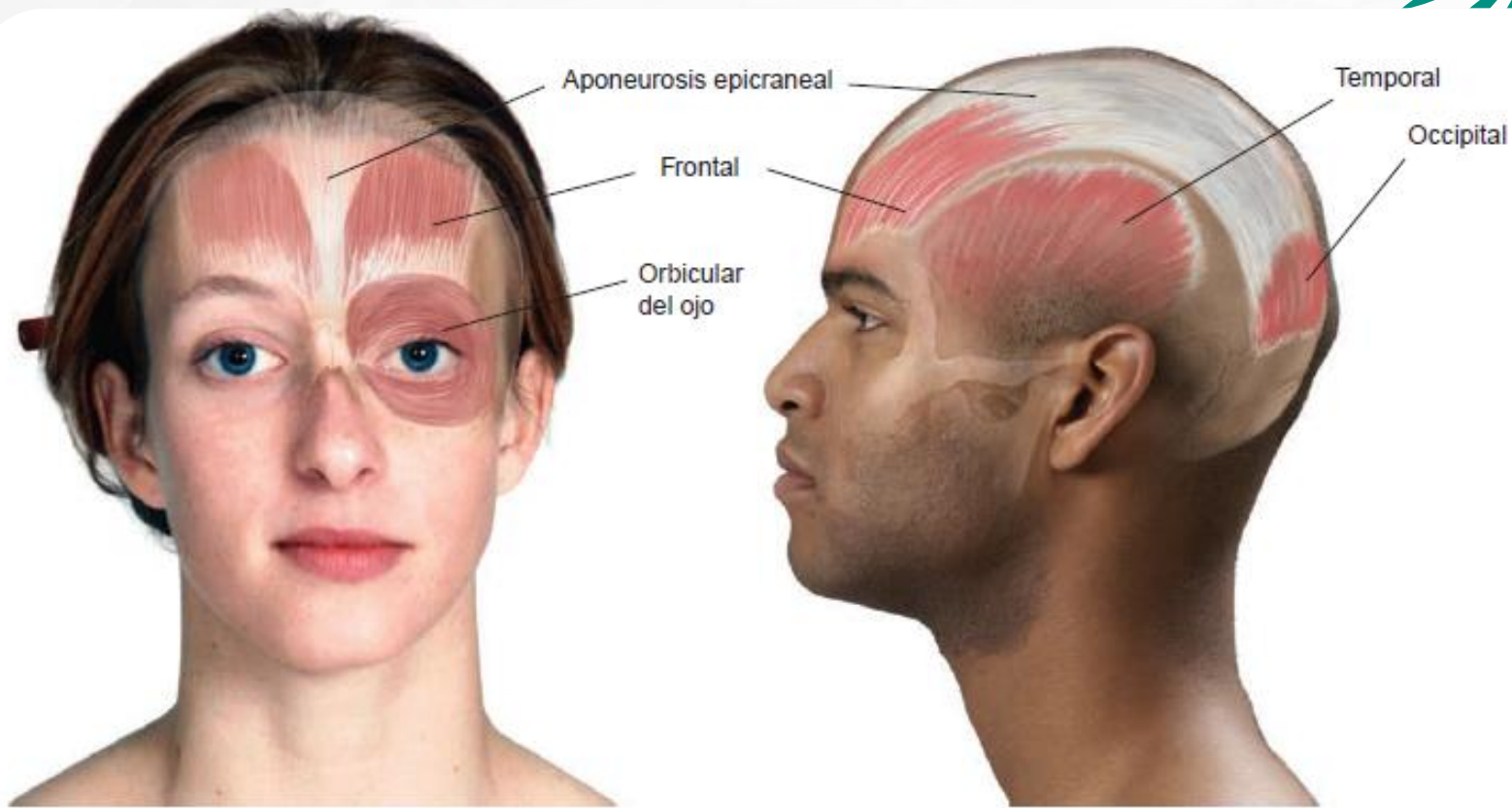
Inserciones

- En la parte superior, en la aponeurosis epicraneal
- En la parte inferior, en la piel que hay sobre la ceja, en el orbicular del ojo y en la base de la nariz



Acciones

- Eleva la ceja y arruga la frente.
- Trabajar en el occipital ayuda a desplazar el cuero cabelludo en sentido posterior, eleva la piel de la frente y levanta el pelo como en una expresión de terror.



- 
- 
- Con los dedos extendidos sobre los laterales de la cabeza del px, coloque los pulgares en el centro de la frente justo por encima de las cejas.
 - Presionando firmemente en el tejido, separe lentamente los pulgares recorriendo toda la frente hasta las crestas laterales del hueso frontal.
 - Desplace las manos sobre la parte superior y repita este proceso hasta la línea de implantación del pelo.



Fricción transversal:



❑ Occipital:



Palpación

Coloque las yemas de los dedos debajo de la cabeza del paciente en decúbito supino, por debajo de las dos prominencias claramente definidas del cráneo. El occipital cubre estas prominencias. La arquitectura del músculo es paralela, y la dirección de las fibras es de superior a inferior.



Inserciones

- En la parte superior, en la aponeurosis epicraneal
- En la parte inferior, en línea nuchal superior del hueso occipital



Acciones

Ancla y retrae la aponeurosis epicraneal, con lo que tira del cuero cabelludo en sentido posterior. Véase Frontal (pág. 74) para más información.

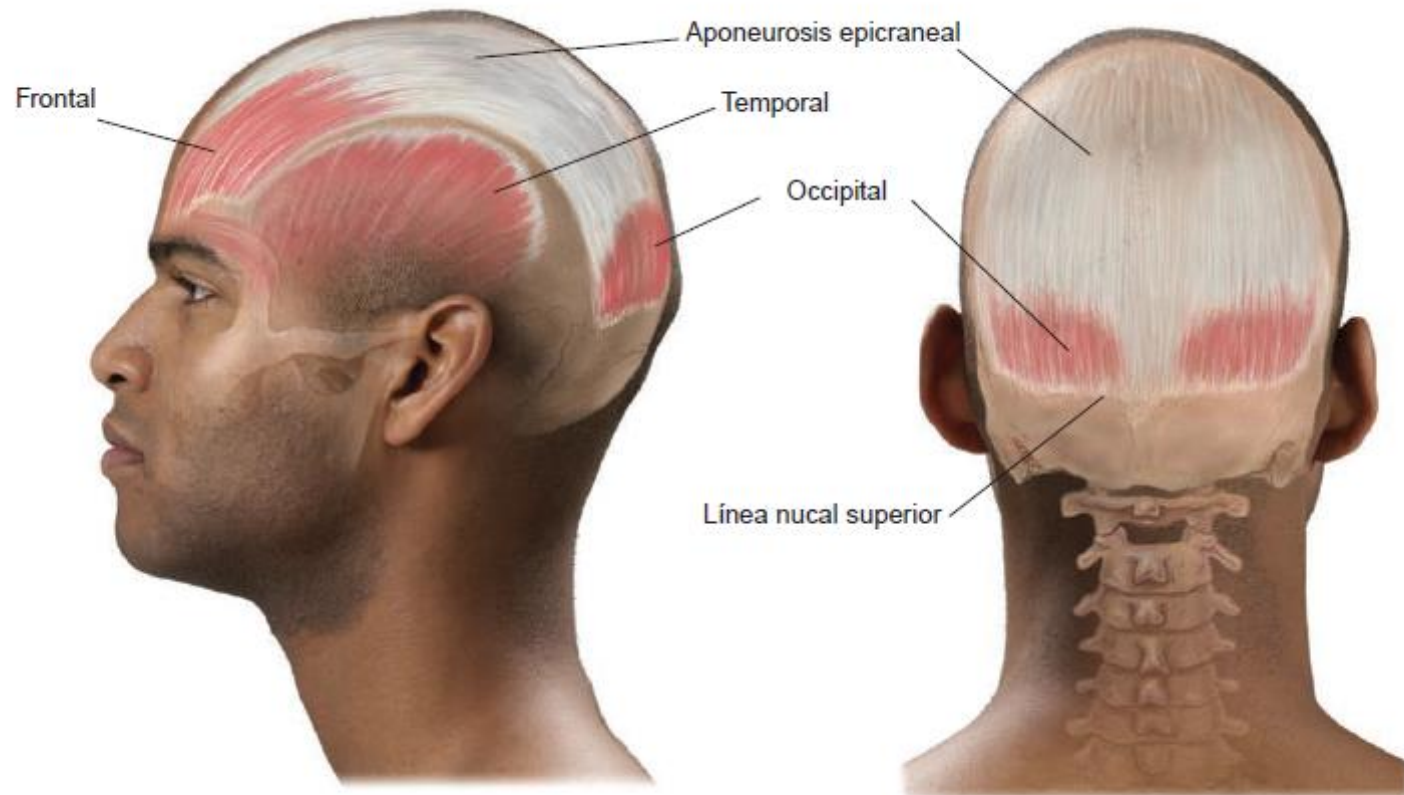


Figura 3-5 Características anatómicas del occipital.

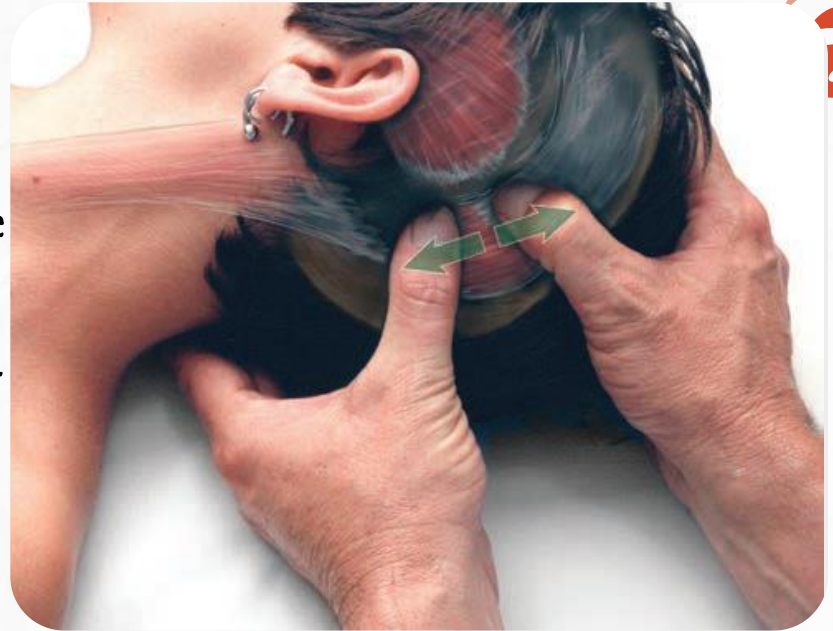
Masaje deslizante (1) :



- Colocar las manos debajo de la cabeza, los dedos flexionados hacia arriba de forma que las yemas de los dedos toquen la base del cráneo.
- Presionar en la parte superior y, usando el peso de la cabeza del paciente para generar presión, desplaza las manos muy lentamente hacia usted de forma que las yemas de los dedos traten todo el vientre occipital
- Deténgase allí donde el paciente le refiera puntos dolorosos.

Masaje deslizante (2) :

- El px se coloca en decúbito supino o prono con la cabeza rotada al lado contrario al terapeuta.
- Sujetar la cabeza del px con las dos manos, de manera que los pulgares descansen sobre la parte central y superior del occipital.
- Presionando firmemente en el tejido, separar los pulgares hasta los límites del vientre muscular
- Desplazando los pulgares a una posición más cerca del cuello, repetir el procedimiento hasta que se haya tratado todo el vientre muscular.



❑ Orbicular del ojo:



Palpación

Este músculo, que no es claramente distinguible, rodea el ojo. La arquitectura del músculo es paralela, y la dirección de las fibras es aproximadamente concéntrica alrededor del ojo.

- ❑ *Rodea el ojo y permite el cierre voluntario del párpado.*



Inserciones

- En la parte medial, se inserta en el ligamento palpebral medial, los huesos frontal y maxilar y en la parte blanda del párpado.
- En la parte superior y medial, en la órbita



Acciones

- Parpadeo intencionado y cierre fuerte del párpado
- Guiño del ojo

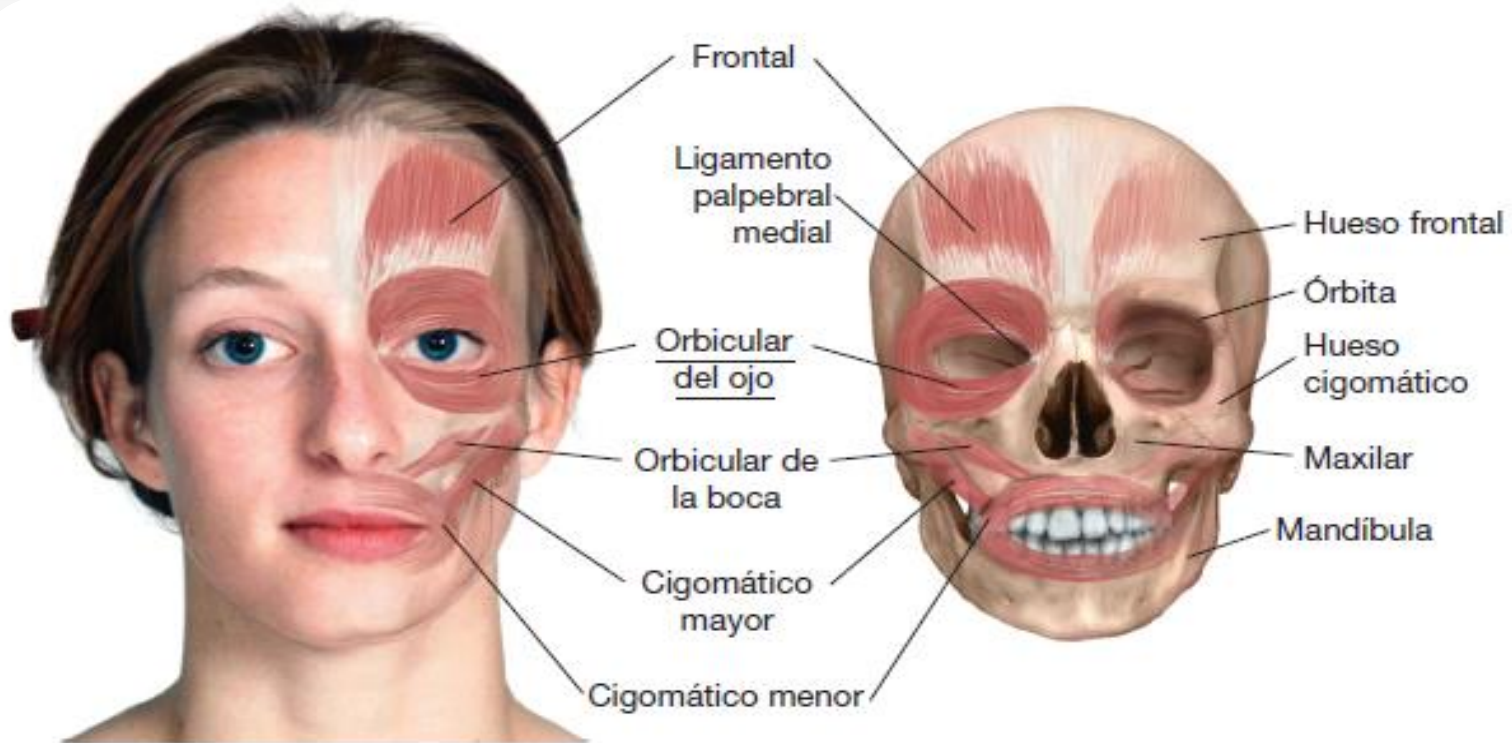


Figura 3-8 Características anatómicas del orbicular del ojo.

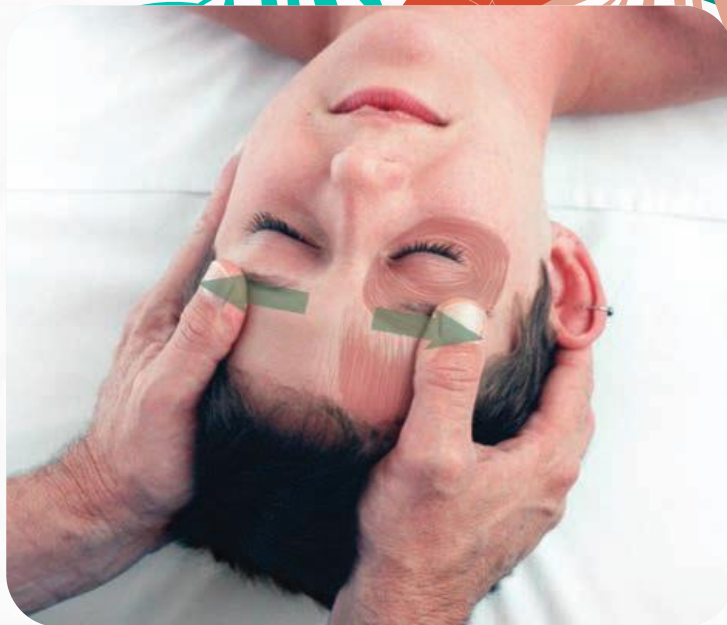
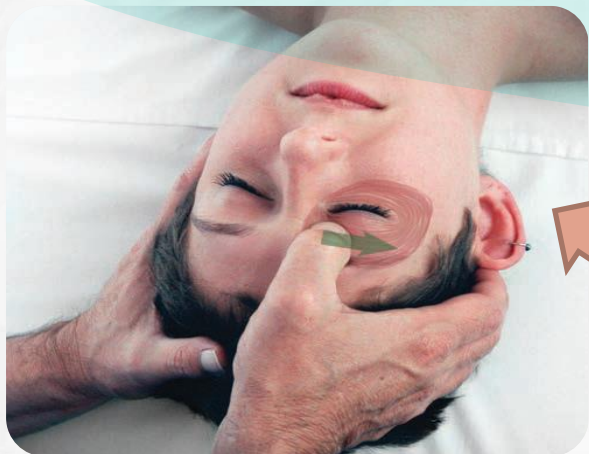
Figura 3-8 Características anatómicas del orbicular del ojo.



Compresión:

- ❑ Usando el pulgar, buscar un punto doloroso común o gatillo cerca del extremo lateral de la ceja.
- Presionar y mantener la presión para liberar

- ❑ Colocar la yema del pulgar o cualquier otro dedo sobre el extremo medial de la ceja.
- ❑ Presionando firmemente en el tejido, deslizar el pulgar o el dedo hacia fuera hasta el extremo lateral de la ceja



- ❖ Repetir una vez inmediatamente por encima de la ceja, y de nuevo inmediatamente por debajo de ella, presionando en la parte superior contra la órbita

Masaje deslizante

Cigomático mayor y menor



Inserciones

- En la parte superior, en el hueso cigomático
- En la parte inferior, se inserta en los tejidos de las comisuras de la boca, mezclándose con las fibras del orbicular de la boca.

- ☐ Son los principales músculos de la risa



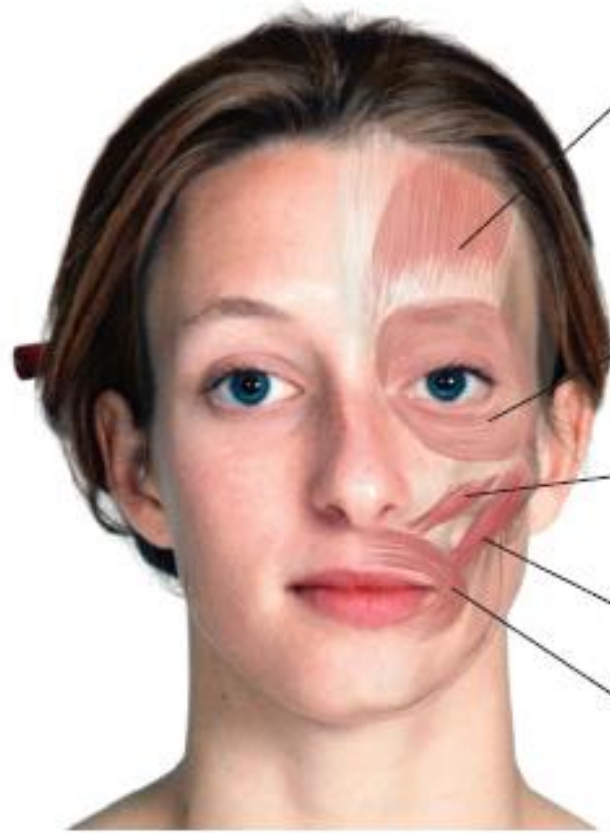
Palpación

Coloque la yema de su dedo índice por debajo de la prominencia cigomática con su cuarto dedo apoyado en la piel situada sobre el diente canino. Al mover las yemas de sus dedos adelante y atrás, podrá sentir el músculo con claridad. La arquitectura del músculo es paralela, y la dirección de las fibras es diagonal.



Acciones

Tirar de las comisuras de la boca hacia arriba y atrás, como en una sonrisa.



Frontal

Ligamento
palpebral
medial

Orbicular
del ojo

Cigomático
menor

Cigomático
mayor

Orbicular de
la boca



Hueso frontal

Órbita

Hueso
cigomático

Maxilar

Mandíbula

Masaje deslizante:



- Coloque el borde del pulgar sobre el hueso cigomático (hueso de la mejilla).
- Presionando firmemente en el tejido, deslice el pulgar lentamente en dirección descendente hasta la comisura de la boca

- Coloque el dedo índice dentro de la boca en la parte interna de la mejilla.
- Coloque la yema del pulgar sobre la parte externa de la mejilla.
- ✓ Usando la palpación con pinza, explore la longitud del músculo en busca de puntos gatillo o puntos dolorosos.
- ✓ Comprima y mantenga cada punto hasta que se libere

Compresión:



Temporal:



Inserciones

- En la parte superior, en el hueso y en la fascia que hay en la fosa temporal por encima del arco cigomático
- En la parte inferior, en la apófisis coronoides de la mandíbula y en la cresta anterior de la rama de la mandíbula



Palpación

El temporal puede palparse entre el hueso esfenoides y la cara posterior del hueso temporal hasta el arco cigomático, y una cantidad muy pequeña justo por debajo del arco. La arquitectura del músculo es convergente y la dirección de las fibras varía de diagonal a superior/inferior. Apenas se distingue cuando está relajado, pero puede apreciarse en algunas zonas en las que está tenso.



Acciones

- Cierra la mandíbula.
- Mueve la mandíbula en sentido posterior y lateral.
- Mantiene la posición de reposo de la mandíbula.

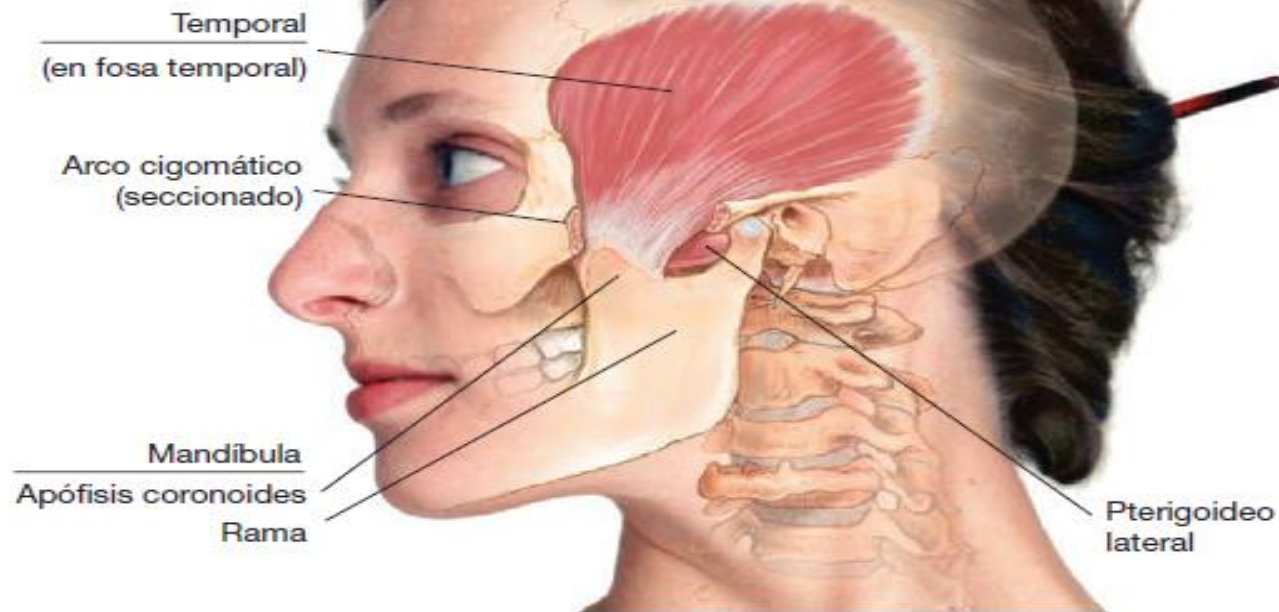


Figura 3-15 Características anatómicas del temporal.

Fricción transversal:

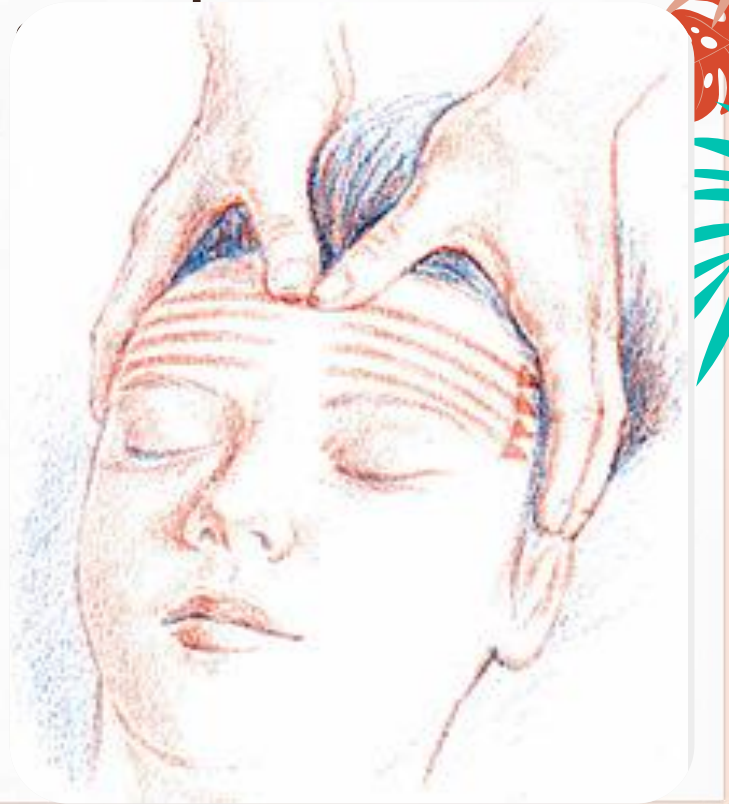
- ❑ Sujetar la cabeza del px con las manos abiertas, y los pulgares apoyados juntos sobre la cara anterior del temporal.
- ❑ Presionando firmemente en el músculo con los bordes de los pulgares, deslícelos separándolos, de manera que cada pulgar se deslice de 2 cm a 5 cm.
- ❑ Mover las manos en sentido posterior, repitiendo el procedimiento, hasta que se cubra todo el músculo temporal.



❑ Dolores de cabeza: Ma

1. Recorrido de la frente

- ❑ De rodillas junto a la cabeza del px, colocar los pulgares en el centro de la frente, encima de las cejas, y el resto de sus dedos cubriéndole las sienes. Lenta pero enérgicamente, deslice los pulgares hacia el arranque del cuero cabelludo. Repita este movimiento varias veces, desplazándose cada vez un poco para cubrirle sucesivamente toda la superficie de la frente.



Presión circular en las sienes



- ✓ Empiece presionando con las yemas de los dedos las sienes del receptor durante unos diez segundos. Afloje poco a poco la presión y haga lentos círculos sobre ambas sienes. Su receptor deberá decirle si la presión que le ejerce es profunda o ligera.

Acomódela a lo que él prefiera.

Masaje del cuero cabelludo en el arranque del pelo

- ❑ Situado detrás del px , haga que su cabeza descansa contra el pecho de usted.
- ❑ Con los dedos de sus manos en «patas de araña», ejerza masaje con las puntas a lo largo de todo el nacimiento del cuero cabelludo, desde el centro de la frente hasta la base del cráneo.
- ❑ Haga este recorrido despacio, ejerciendo tanta presión como el px lo necesite.



1. Shiatsu. Masaje del cuero cabelludo



- ❑ Incline la cabeza del receptor hacia adelante y sosténgale la frente con la palma de su mano izquierda.
- ❑ Con la derecha, ejerza un masaje sobre todo el cuero cabelludo, con todos los dedos, como si le friccionara el cabello para lavárselo, y cubriendo con este movimiento toda la superficie del cuero cabelludo.
- ❑ Concentre su atención en aquellas zonas más sensibles de la piel.

Cara:





Beneficios del masaje facial:

- ✓ *Tonifica los músculos faciales y alivia la tensión.*



- *Estimula la circulación*

- Libera toxinas. las toxinas se acumulan en nuestra piel, contribuyendo a las líneas finas, hinchazón y brotes de acné .

- ❖ Podemos llegar a reactivar la producción de colágeno, lo que obviamente, tendrá un efecto de rejuvenecimiento



Masetero:



Palpación

El masetero se palpa claramente desde por debajo del arco cigomático hasta la mandíbula. Se palpa en su cara interna colocando el dedo enguantado dentro de la boca contra la mejilla y presionando en su cara posterior. La arquitectura del músculo es paralela, y la dirección de las fibras es superior/inferior.



Inserciones

- En la parte superior, en la apófisis cigomática del maxilar y en el arco cigomático
- En la parte inferior, la capa superficial del músculo se inserta en la superficie externa de la mandíbula en el ángulo y en la mitad inferior de su rama; la capa profunda del músculo en la mitad superior de la rama, posiblemente extendiéndose al ángulo de la mandíbula.



Acciones

Eleva la mandíbula junto al temporal y el pterigoideo.

- ❑ *Es el músculo masticador más prominente. Debe tratarse en primer lugar en los problemas de la ATM, ya que está en una posición que tiene un acceso fácil.*

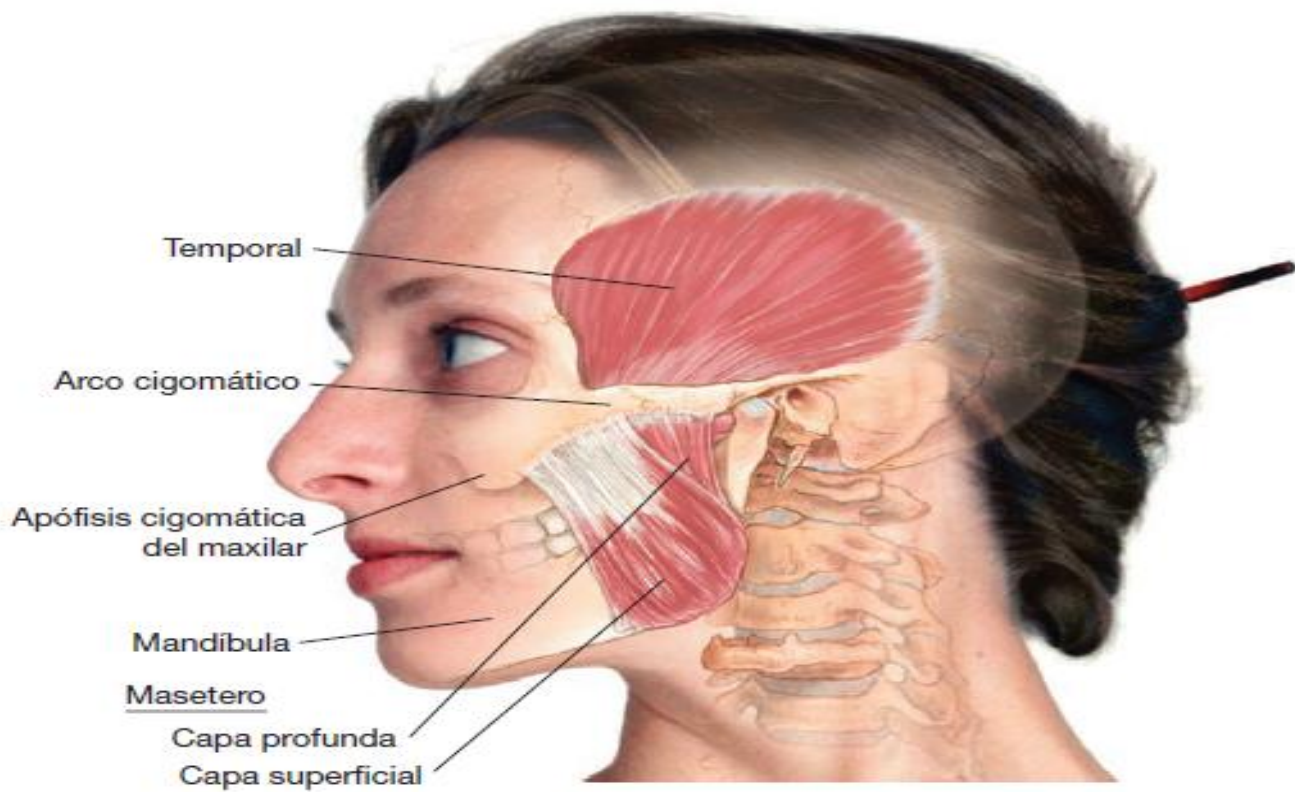


Figura 3-17 Características anatómicas del masetero.

Figura 3-17 Características anatómicas del masetero.

Capa superficial

Capa profunda

Masaje deslizante:

- Coloque el pulgar o las yemas de los otros dedos en la cara superior del músculo, anterior a la abertura del conducto auditivo externo.
- Presionando firmemente hacia dentro, deslizar el o las yemas de los dedos hacia abajo a lo largo de todo el músculo hasta la mandíbula.
- Deténgase en las barreras o puntos dolorosos hasta que se perciba la liberación.
- Cuando se encuentre una zona muy dolorosa, repetir el proceso anterior comenzando con suavidad y presionando con más profundidad cada vez.



Pterigoideo lateral o externo



Inserciones

Inserciones del superior:

- En la parte superior, en la cresta infratemporal y en la superficie inferolateral del ala mayor del esfenoides
- En la parte inferior, en la superficie lateral de la lámina lateral de la pterigoides

Inserciones del inferior:

- En la parte superior, hacia atrás y algo hacia abajo hacia la ATM, se inserta en el ligamento de la cápsula articular, en el disco articular y en la lámina lateral de la pterigoides del esfenoides.
- En la parte inferior, en dirección diagonal hacia arriba, en el cuello condíleo y rama de la mandíbula inmediatamente por debajo de la articulación, en el cuello de la mandíbula, el disco articular y la cápsula de la articulación temporomandibular



Acciones

- Las dos divisiones de este músculo participan en la elevación y el descenso de la mandíbula, así como en el movimiento de la mandíbula en sentido posterior, anterior y lateral.
- Desciende y retrae la mandíbula.
- Actuando de forma alternante, produce un movimiento de rechinar de dientes.



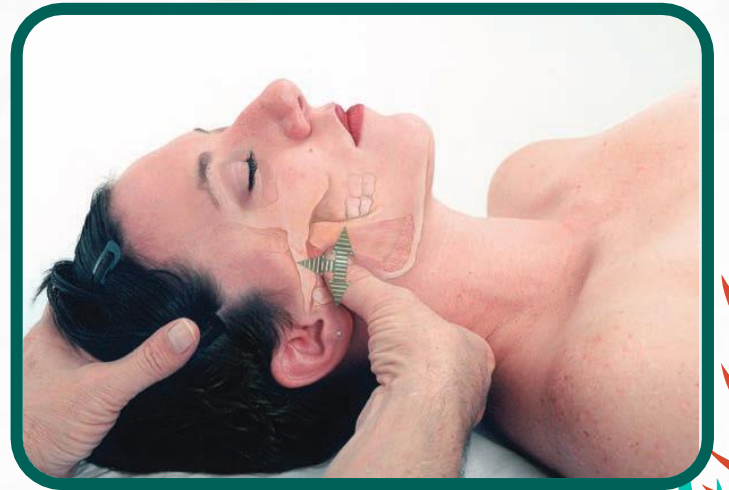
Palpación

Los pterigoideos son palpables en tres zonas principales: 1) directamente entre el maxilar y la mandíbula anterior a la articula-

ción, 2) a lo largo de la superficie medial de la mandíbula en la cara lateral de la cara y 3) en la zona interna presionando en sentido lateral a la articulación entre el maxilar y la mandíbula. Las arquitecturas de los músculos son paralelas, y la dirección de las fibras varía.

Compresión externa (1):

- Use el pulgar para encontrar el espacio inmediatamente anterior a la **ATM**.
- Comprima hacia arriba, hacia abajo y hacia delante buscando los puntos dolorosos. Manténgase en cada punto doloroso hasta que se alivie.



COMPRESIÓN EXTERNA (2)



- Coloque el pulgar o dos yemas de los dedos inmediatamente por debajo del ángulo de la mandíbula.
- Presione en la parte superior y dentro de la superficie medial de la mandíbula, moviéndose lenta y suavemente, buscando puntos dolorosos.
- Comprima cualquier punto doloroso contra la superficie medial de la mandíbula

Cuello:



Downloaded from
Dysparemia.com

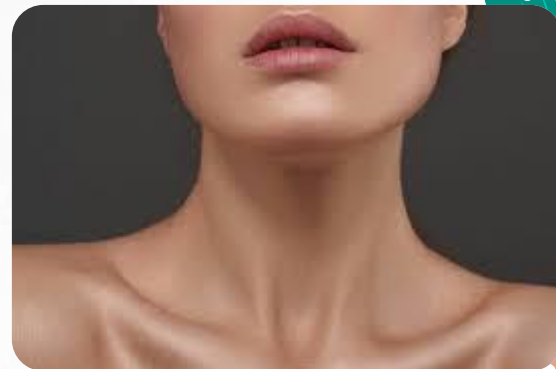
Downloaded from
Dysparemia.com



El cuello tiene dos funciones esenciales:

- Conecta la cabeza y sus funciones con el resto del cuerpo.
- Sujeta y mueve la cabeza.

- ❖ Como un puente entre la cabeza y los hombros, el cuello es un centro vital donde se desarrollan gran cantidad de funciones. Las arterias y venas que pasan por el interior aseguran el riego sanguíneo entre la cabeza y el resto del cuerpo.



Platisma:

- ❑ Es un músculo subcutáneo plano y liso. Se dispone paralelo al esternocleidomastoideo, y sus puntos gatillo tienden a aparecer junto a este músculo.



Inserciones

- En la parte superior, en la comisura de la boca y en los otros músculos faciales de esa región, y en la cara inferior de la mandíbula
- En la parte inferior, en la fascia superficial de la porción superior y anterior del tórax



Palpación

Este músculo no suele ser discernible, aunque algunos pueden percibir sus bordes en el cuello inmediatamente por debajo de la porción media de la mandíbula.



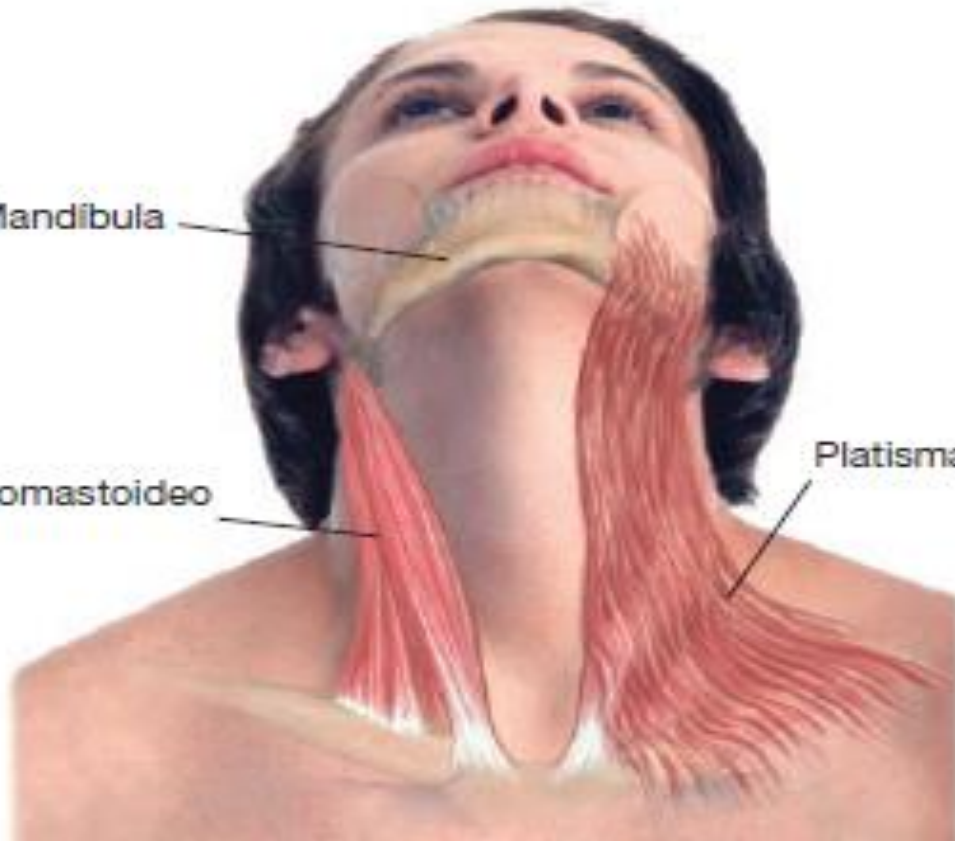
Acciones

- Tira de la comisura de la boca hacia abajo y de la piel del tórax hacia arriba.
- Tensa la piel del cuello (como en un gesto de terror).

Mandibula

Esternocleidomastoideo

Platisma



Masaje deslizante

- Coloque el yemas de los dedos sobre el tórax 5 cm o 7 cm por debajo de la clavícula, inmediatamente medial a la porción anterior del deltoides.
- Presionando firmemente en el tejido, deslice las yemas de los dedos en la parte superior sobre la clavícula y hasta el cuello, después sobre la mandíbula y hasta la mitad de la mejilla.
- Desplace las yemas de los dedos en la parte medial hasta la siguiente zona descubierta y repita el procedimiento , terminando la presión en la boca.
- Repetir el procedimiento a través del tórax, comenzando la última presión en el esternón.



Digástrico

- ❖ Grupo de músculos que se insertan al hueso hioides, está cerca del estilohioideo y es difícil de distinguir de él



Inserciones

- En la parte inferior, los dos vientres se insertan en el hueso hioides.
- En la parte superior, el vientre posterior se inserta en la apófisis mastoideas por debajo del longísimo de la cabeza, el esplenio de la cabeza y el esternocleidomastoideo; el vientre anterior se inserta en el borde inferior de la mandíbula, cerca del centro.



Palpación

El digástrico es palpable por debajo del pabellón auricular y de la mandíbula, pero no es fácil de distinguir.



Acciones

- Baja la mandíbula (abriendo la boca).
- Eleva el hueso hioides.
- Retrae la mandíbula.
- Participa en la deglución y la tos.
- Sujeta el hioides durante la tos, la deglución y el estornudo.

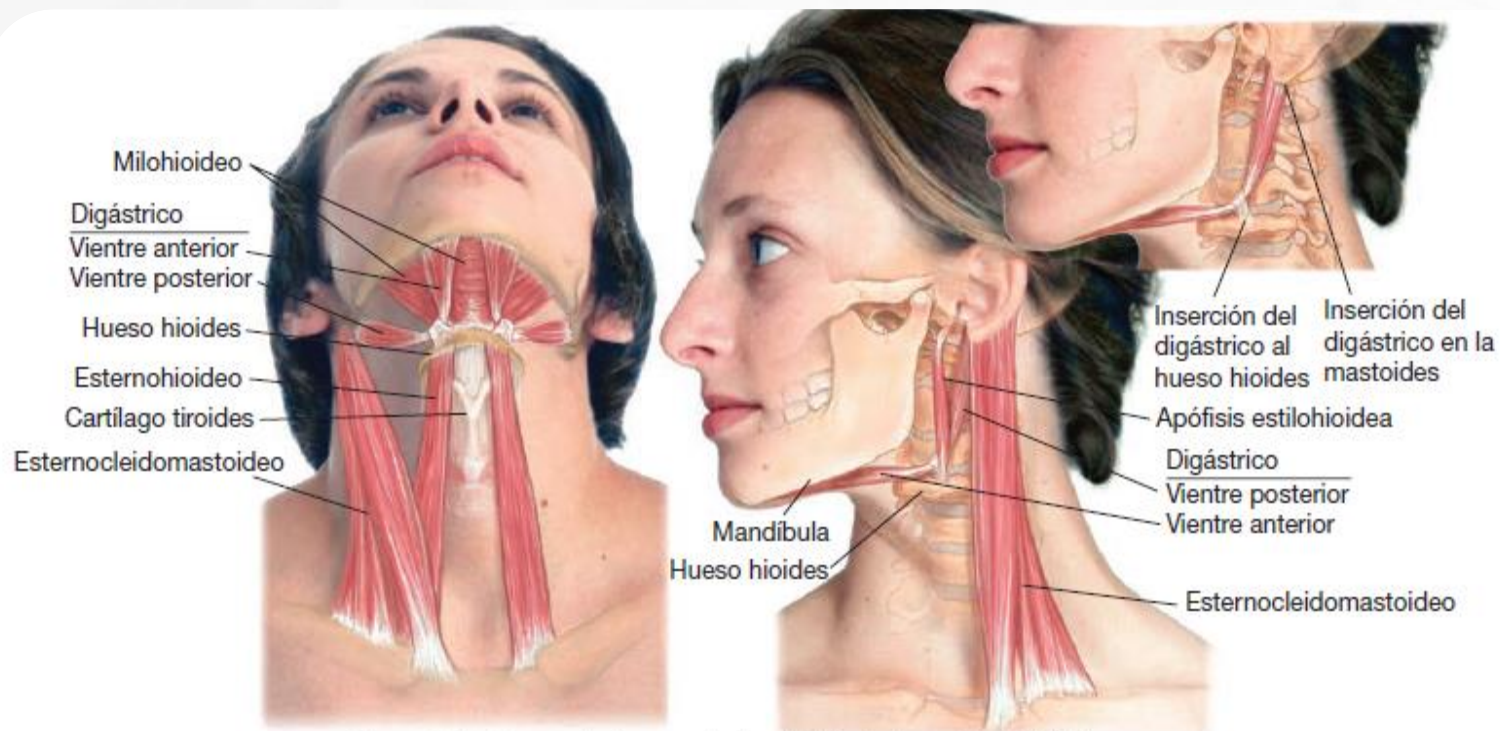


Figura 3-34 Características anatómicas del digástrico y el estilohioideo.

Figura 3-34 Características anatómicas del digástrico y el estilohioideo.

Masaje deslizante



- Localice con suavidad el hueso hioides usando la yema del pulgar o del dedo índice.
- Coloque la yema del pulgar o de otro dedo inmediatamente superior a un lado del hueso hioides.
- Presionando suavemente, siga el vientre posterior hasta la apófisis mastoides
- Comenzando en la misma posición, siga el vientre anterior hasta un punto situado a un lado del centro de la cara interna de la mandíbula.
- Deténgase cuando encuentre dolor y espere que ceda.
- Repetir en el lado opuesto.

Esternocleidomastoideo



Inserciones

En la parte superior:

- Se inserta en la superficie lateral de la apófisis mastoides y en la mitad lateral de la línea nuchal superior del hueso occipital.



Palpación

Coloque al paciente en decúbito supino, con la cabeza rotada hacia un lado y separada de la camilla. En la mayoría de los pacientes, la cabeza esternal del músculo será evidente de inmediato, y puede palparse desde la apófisis mastoides hasta la inserción esternal. La cabeza clavicular es muchos menos evidente a la vista, pero también puede palparse desde la apófisis mastoides hasta la inserción en la porción posterior de la clavícula.

- ❑ Músculo de dos cabezas con la mayor responsabilidad en la estabilización, giro y flexión la cabeza y el cuello. Es también un lugar común de muchos puntos gatillo que producen varias cefaleas.

En la parte inferior:

- Cabeza esternal, en la superficie anterior del manubrio
- Cabeza clavicular, en el tercio medial de la superficie anterior de la clavícula



Acciones

Bilateral:

- Estabiliza la cabeza y el cuello.
- Resiste la hiperextensión del cuello y el movimiento hacia atrás de la cabeza (latigazo).
- Flexiona el cuello.
- Participa en cierta medida en la deglución y la respiración.

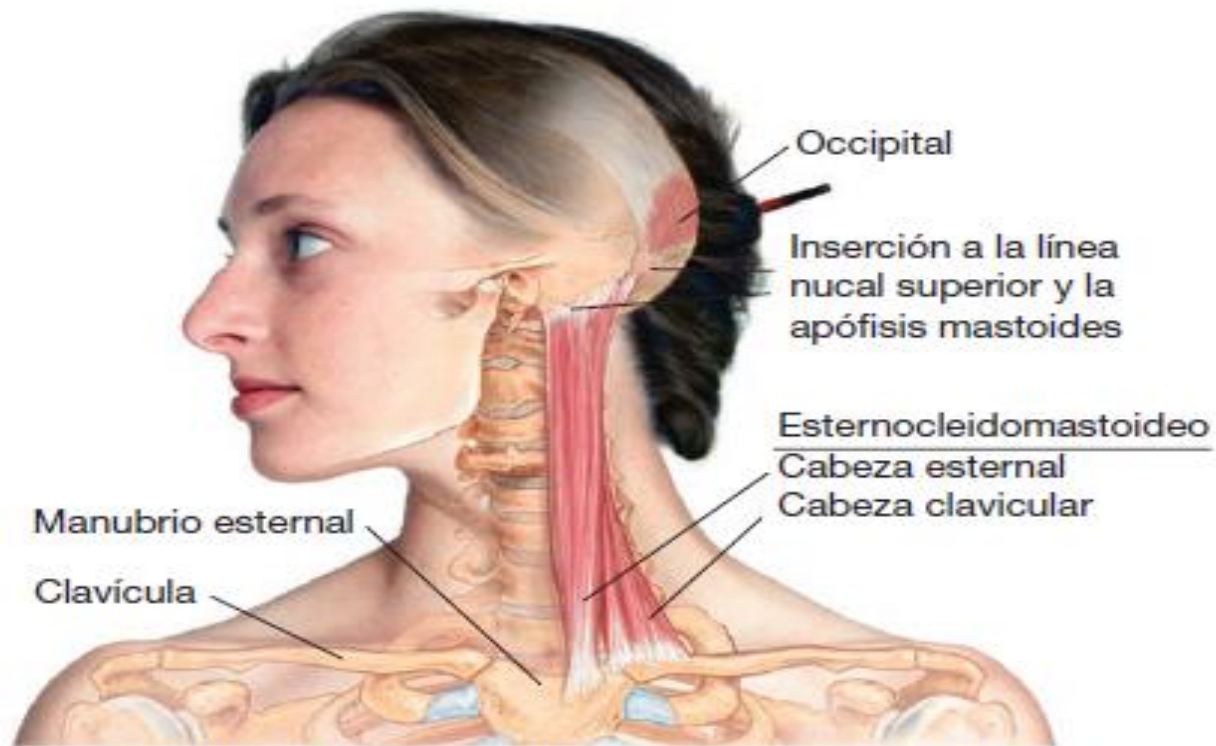


Figura 3-36 Características anatómicas del ECM.

Masaje deslizando

- Sujete la cabeza del px con una mano y rótela ligeramente hacia el lado opuesto al músculo en el que quiere trabajar.
- Coloque el pulgar o las yemas de los dedos de la otra mano sobre la inserción del músculo en la apófisis mastoides.



- ✓ Presionando firmemente en el tejido, deslice el pulgar o las yemas de los dedos lentamente hacia abajo por la cabeza esternal hasta la inserción en el manubrio, deteniéndose en los puntos dolorosos hasta que se alivien
- ✓ Comenzando de nuevo en la inserción superior, repetir el proceso sobre la cabeza clavicular hasta la inserción en la clavícula

Compresión en pinza

- Mantener la cabeza del px en una mano, apoyando con firmeza su parte posterior y la base del cráneo.
- Elevar la cabeza algunos centímetros para que destaque el esternocleidomastoideo; rote la cabeza ligeramente para alejarla del lado en que pretende trabajar.



- Comenzando tan cerca como sea posible de la inserción mastoidea, agarrar la cabeza esternal entre el pulgar y el lateral del dedo índice o las yemas de los dedos índice y medio
- Comprima con firmeza pero con suavidad, pidiendo al paciente que le diga si nota molestias o dolor. Si hay dolor, mantenerse hasta que ceda.
- Desplazar los dedos hacia abajo ligeramente, repitiendo hasta que llegue lo más cerca posible al manubrio.
- Rotar la cabeza del paciente un poco más desde el lado en que esté trabajando y repetir el proceso anterior con la cabeza clavicular. Observe que esta cabeza es más difícil de acceder, ya que se sitúa a mayor profundidad que la cabeza esternal.
- Repetir todo el proceso en el otro lado.



Escalenos:



Inserciones

Escaleno anterior:

- En la parte superior, en la parte anterior de las apófisis transversas de C3 a C6
- En la parte inferior, en el borde superior interno de la primera costilla

Escaleno medio:

- En la parte superior, en la parte posterior de las apófisis transversas de C2 a C7
- En la parte inferior, en el borde superior externo de la primera costilla



Palpación

La trayectoria de los escalenos puede seguirse colocando las yemas de los dedos inmediatamente por delante del trapecio y por debajo de la apófisis mastoides (no se insertan aquí, pero son discernibles aquí por primera vez) y siguiéndolos hacia abajo hasta sus respectivas inserciones en las costillas y la cúpula pleural. El escaleno posterior puede seguirse a partir del borde anterior del trapecio. El escaleno anterior puede seguirse desde inmediatamente por debajo de la apófisis mastoides hacia la primera costilla. El escaleno me-

- Se les conoce por su facilidad para presentar dolor referido. Aunque tienen la función bastante sencilla de inclinar la cabeza a cualquiera de los lados.

Escaleno posterior:

- En la parte superior, a la parte anterior de las apófisis transversas de C5 o C6 y C7
- En la parte inferior, a la superficie lateral de la segunda costilla, y a veces de la tercera

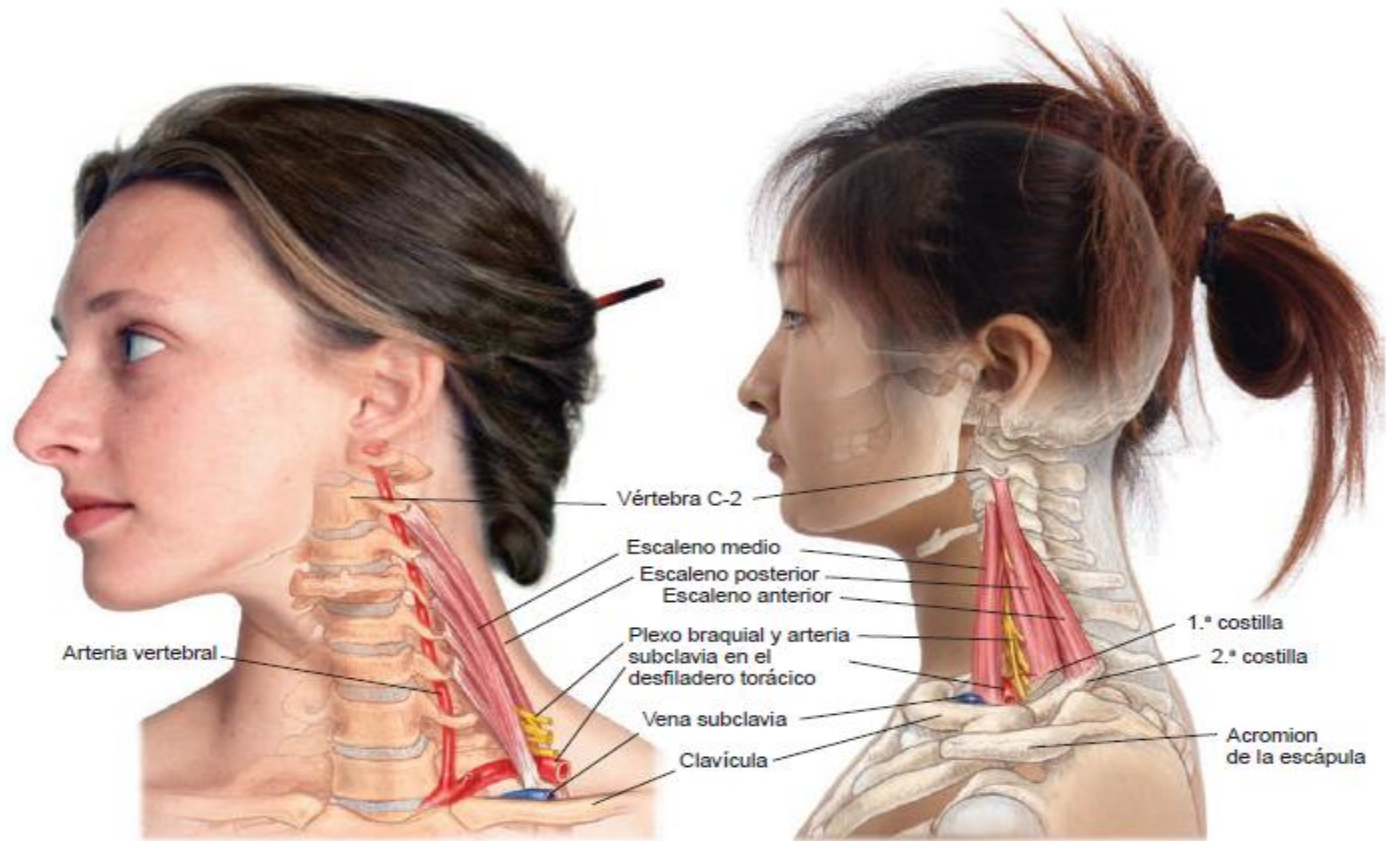
Escaleno menor (se encuentra en la mayoría de las personas, pero no en todas):

- En la parte superior a la parte anterior de las apófisis transversas de C7
- En la parte inferior, a la parte superior de la cúpula pleural y el borde interno de la primera costilla



Acciones

- Sobre todo flexores laterales de la columna cervical
- Escalenos anteriores: ayudan a flexionar el cuello en los dos lados.
- Escalenos posteriores: estabilizadores del cuello, participan en la inspiración, también tienden a participar en la elevación de la parrilla costal al levantar y transportar objetos.



Masaje deslizante (1)

- Colocarse de pie junto a la cabeza del px. Sujetar la cabeza por debajo con una mano.
- Colocar los dedos de la otra mano debajo del cuello del paciente, y con el pulgar buscar la parte superior del escaleno anterior
- Presionando firmemente en el tejido, deslizar el pulgar lentamente a lo largo del músculo hasta donde pueda alcanzar hacia el interior del espacio que hay por debajo de la clavícula.



- Repetir el proceso, esta vez buscando el escaleno medio.
- Repetir el proceso, esta vez buscando el escaleno posterior y siguiendo tanto como pueda hasta el espacio que hay inmediatamente por delante del borde del trapecio
- Repetir todo el proceso en el otro lado.



COMPRESIÓN PROFUNDA



- ✓ Colocarse de pie o sentado junto a la cabeza del paciente.
- ✓ Coloque las yemas de los dedos sobre los escalenos en la base del cuello. Presionar en profundidad en los tejidos en una dirección diagonal hacia el tórax en el lado opuesto del paciente.
- ✓ Mantenga hasta la liberación de los músculos

Masaje deslizante (2)

- Decúbito prono.
- Colocarse mirando en dirección craneal.
- Sujetar la cabeza de forma estable con una mano, y buscar la porción superior del escaleno medio con el otro pulgar.
- Presionando firmemente en el tejido inmediatamente anterior al borde de trapecio deslizar el pulgar a lo largo del escaleno anterior todo lo que pueda.
- Repetir para el escaleno posterior.
- El procedimiento previo puede realizarse también usando los nudillos



Masaje deslizante (3)



- El px está sentado.
- Colocarse detrás del paciente sentado.
- Colocar el pulgar sobre el escaleno medio en su inserción superior .
- Presionando en profundidad en el tejido, deslizar el pulgar a lo largo del músculo hasta su inserción inferior.
- Repetir el procedimiento anterior

Trapezio

Los problemas en el trapecio pueden provocar mucho dolor y molestias. Es el músculo más tratado en los masajes de espalda



Inserciones

Trapezio superior:

- En la parte superior y en la parte medial, se inserta en la línea nuchal superior, en el ligamento nuchal y en las apófisis espinosas de C1 a C5.
- En la parte inferior y lateral, en el tercio externo de la clavícula

Trapezio inferior:

- En la parte medial, en las apófisis espinosas y en ligamentos de T4 a T12
- En la parte lateral, en el extremo medial de la espina de la escápula, a continuación de la inserción inferior del elevador de la escápula

Trapezio medio:

- En la parte medial, en las apófisis espinosas y en los ligamentos de C6 a T3
- En la parte lateral, en el acromion y en la cara superior de la espina de la escápula



Acciones

- Eleva la escápula (con el elevador de la escápula).
- Rota la escápula hacia arriba (mueve la fosa glenoidea hacia arriba).
- Retrae la escápula (tirando de ella hacia la columna vertebral).
- Desciende la escápula.
- Extiende la cabeza y el cuello (acción bilateral).
- Gira la cabeza y el cuello (acción unilateral).

Trapeccio:



Palpación

El trapecio es el más fácil de palpar en los hombros, donde suele estar casi siempre tenso, agarrándolo simplemente con la mano. Podemos seguirlo por el cuello hasta la línea nual superior desde ese punto. No es fácil de distinguir en la parte superior de la espalda, excepto en los bordes, aunque ello dependerá de la posición y desarrollo individual del músculo. La arquitectura es muy variable, pero es en gran medida convergente.

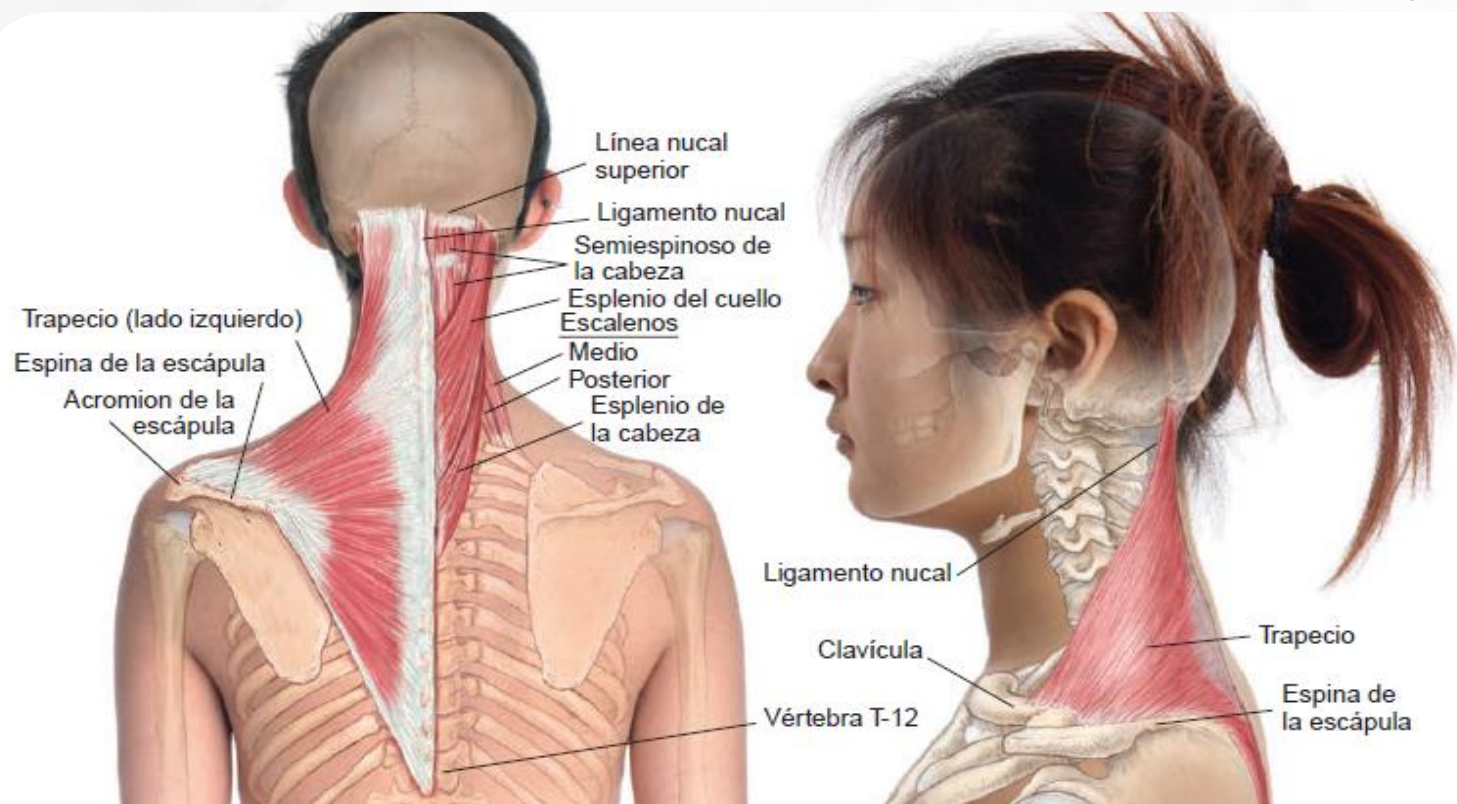
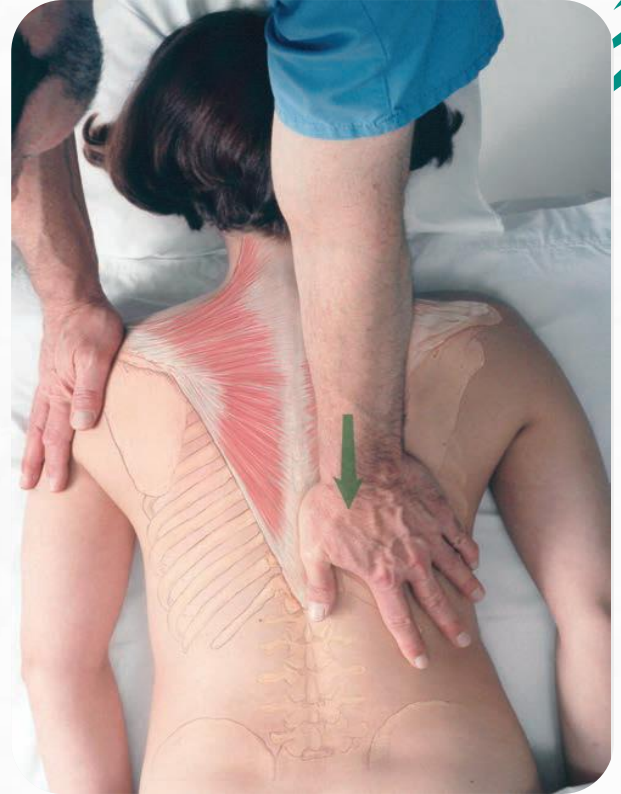


Figura 3.48 Características anatómicas del trapecio

PÉTRISSAGE (AMASAMIENTO)

- *Situarse de pie al lado del px en decúbito prono junto al codo, mirando la cabeza del px.*
- *Colocar las dos manos sobre el hombro del px en el trapecio superior.*
- *Traccionar y empujar el tejido, primero con una mano y después con la otra, comenzando suavemente y aumentando la fuerza de su agarre a medida que el tejido se relaje.*
- *Para finalizar, agarrar el músculo con una mano y sacudirlo varias veces.*
- *Moverse al otro lado del paciente y repetir el procedimiento.*



Compresión en pinza

- *Situarse de pie al lado del px en decúbito prono junto al codo, mirando la cabeza del px*
- *Coloque la mano que está más cerca de la cabeza del paciente sobre el trapecio superior*
- *Agárrelo firmemente entre los dedos y el pulgar, y manténgalo. Comience con un agarre suave, evaluando el tejido y aumentando la fuerza del agarre a medida que el tejido se relaje*
- *Alternar sujetando el tejido con un movimiento de delante atrás del pulgar y los dedos*



Músculos suboccipitales



Acciones

- Extiende y rota la cabeza.
- Inclina la cabeza hacia el mismo lado.



Inserciones

El oblicuo inferior de la cabeza se conecta con las dos primeras vértebras cervicales; el resto de los músculos conecta las dos primeras vértebras cervicales con el hueso occipital.

- ❑ Oblicuo superior de la cabeza, oblicuo inferior de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza



Masaje transversal



- De pie frente a la cabeza del px y mirándole, coloque una mano debajo del cuello del px en la base del occipucio y curve las yemas de los dedos dentro de la cara lateral de los músculos de la región posterior del cuello
- Presionando firmemente en el tejido, continúe flexionando los dedos, retirando las yemas hacia usted que alcancen la columna.
- Mover la mano hacia abajo hasta la base del cuello y repetir.
- Repetir en el otro lado.

- Decúbito prono.
- De pie frente a la cabeza del px y mirando al cuello, mantener la cabeza estable con la mano distal.
- Colocar las yemas de los dedos sobre el lado más alejado del cuello del paciente y la yema del pulgar sobre la columna cervical en la base del cráneo.
- Presionando firmemente en el tejido, deslice el pulgar a través de los músculos del cuello hacia los dedos (NOTA: En la base del cráneo, dirija su presión parcialmente contra el hueso occipital).
- Desplazar la mano hacia abajo por el cuello 2 cm a 5 cm y repetir el proceso; repetir hasta que alcance la base del cuello.
- Moverse al lado opuesto del paciente y repetir el procedimiento en el otro lado.

Masaje transversal con el pulgar



Rigidez en el cuello, artritis y tensiones:



- La rigidez del cuello es causado por: dormir en mala postura, resfriado, tirón de músculos o ligamentos, movimientos bruscos, procesos de ansiedad.

1. Fricción y estirado de la parte posterior del cuello

- ✓ Con el px boca arriba, use alternativamente ambas manos para friccionar la parte trasera del cuello, desde la base del cráneo. Ponga sus manos ahuecadas debajo de la nuca y tire hacia usted, alargando el cuello.
- ✓ No presione ni roce las orejas.
- ✓ Deslice las manos siguiendo la curva de la cabeza, por detrás, hasta llegar a su parte alta.



Amasado del músculo de la base del cuello



- ❑ Deslice su mano hacia abajo por un lado del cuello y agarre el músculo de hombro entre sus dedos. Lentamente, tire y amase el músculo, empujando con los dedos en movimientos circulares hasta alcanzar todos los puntos de esa zona.
- ❑ Preguntar al px si los efectos que siente son particularmente agradables.
- ❑ Repita la secuencia desde el movimiento 2 en el otro lado.

Masaje en el cuello con el receptor sentado

- Con el px sentado frente a una mesa, con los codos sobre ella y sosteniéndose la cabeza con las manos, apriete y friccione los lados y parte de detrás del cuello con rítmicos movimientos.
- Deje que su compañero o compañera le indique cuánta presión necesita. Intente también masajear la parte superior de los hombros y la base del cuello con lento pero firme amasamiento sobre todo el recorrido del músculo del cuello.



- **Actividad para la clase**
- Formar un grupo de 5 integrantes colocarse en una camilla y poner en practica las técnicas visualizadas en clase.

- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿Qué dificultades tuvimos?
- ¿Para que nos sirve lo aprendido?



. CONSULTAS



- Fernández, A. (2015). Masoterapia. Técnicas y fundamentos. Editorial Médica Panamericana. Libro completo y actualizado sobre técnicas de masaje, indicaciones, contraindicaciones y fundamentos anatómicos.
- Sánchez, M. A., & Pérez, J. (2012). Masaje terapéutico: Principios y práctica. Editorial Elsevier España. Cubre tipos de masajes, patologías tratadas, y fundamentos fisiológicos. Castañer, M., & Camerino, O. (2001).
- Técnicas de masaje terapéutico y deportivo. Paidotribo. Enfocado en el ámbito deportivo, con descripciones prácticas de técnicas y aplicaciones.
- Beardsley, C. (2020). The Science and Practice of Manual Therapy. Churchill Livingstone. Muy citado en fisioterapia y masoterapia; cubre biomecánica, evidencia y práctica clínica. Benjamin, B., & Lamp, S. (2005).
- Understanding Sports Massage. Human Kinetics. Enfocado en el masaje deportivo y la recuperación muscular.

Muchas gracias

Presente.